



Collection MedWIZ

6^e année médecine

MALADIES SYSTÉMIQUES

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

I. Cours :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Maladies auto-immunes chez l'enfant	8				
02	Syndrome de Sjögren	12				
03	Syndrome des antiphospholipides (SAPL)	14				
04	Maladie de Behçet	16				
05	Déficits immunitaires	20				
06	Sclérodémie systémique	22				
07	Vascularites systémiques	28				
08	Myopathies inflammatoires (Myosites)	30				
09	Lupus érythémateux systémique (LES)	34				
10	Maladies auto-inflammatoires (MAI)	40				
11	Amyloses	42				
12	Vascularites pédiatriques	44				
13	Approche des maladies rares	46				
14	Granulomatoses systémiques	48				
15	Principes du traitement et du suivi des maladies systémiques	50				

II. Travaux dirigés :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
16	Thrombophilie	54				
17	Acrosyndrome	56				
18	Bilan inflammatoire	60				
19	Bilan d'auto-immunité	62				
20	Fièvre prolongée	64				

Partie I

© 2026 The WIZ / Tous droits réservés.

Cours

© 2026 The WIZ. Tous droits réservés.

MALADIES AUTO-IMMUNES CHEZ L'ENFANT (1)

I. INTRODUCTION

- Définition : Réaction immunitaire anormale contre les constituants de l'organisme (rupture de la tolérance au soi) → inflammation chronique et lésions tissulaires.
- Épidémiologie :
 - 5 à 10% des maladies auto-immunes de l'enfant
 - Sex-ratio ♀/♂ = 4:1
 - Incidence augmente avec l'âge (pic à l'adolescence)
- Physiopathologie :
 - Rôle du CMH/HLA : "carte d'identité" cellulaire et présentation d'antigènes
 - Tolérance centrale (sélection négative dans thymus/moelle)
 - Tolérance périphérique (organes lymphoïdes secondaires)
- Étiopathogénie (6 facteurs) :
 1. Génétique (HLA, CTLA-4, PTPN22, déficits en complément)
 2. Environnementaux (infections, médicaments, toxines)
 3. Hormonaux (œstrogènes)
 4. Immunologiques (défaut Treg, hyperactivation B)
 5. Nutritionnels (vitamine D, microbiote)
 6. Épigénétiques (méthylation, acétylation)

III. CLASSIFICATION

Maladies spécifiques d'organes	Maladies systémiques (connectivites + vascularites)
Thyroïdites (Hashimoto, Basedow)	Lupus érythémateux disséminé (LED)
Diabète de type 1	Dermatomyosite juvénile
Maladie d'Addison	Sclérodermie systémique
Hépatites auto-immunes	Syndrome de Sjögren
Maladie coeliaque	Connectivites mixtes
Sclérose en plaques	Vascularites (Kawasaki, Behçet, etc.)

III. PRINCIPALES CONNECTIVITES

1. LUPUS ÉRYTHÉMATEUX DISSÉMINÉ (LED)

- Définition : Auto-anticorps anti-nucléaires → atteinte multiviscérale.
- Caractéristiques :
 - ♀/♂ = 9/1, début 15-40 ans
 - Physiopathologie : auto-anticorps (anti-ADN, anti-Sm) + complexes immuns + hypocomplémentémie
- Critères ACR (4/11) :
 1. Rash malaire
 2. Lupus discoïde
 3. Photosensibilité
 4. Ulcérations buccales
 5. Arthrites non érosives (≥ 2 articulations)
 6. Atteinte des séreuses (pleurésie/péricardite)
 7. Atteinte rénale (protéinurie $>0,5g/j$)
 8. Atteinte neurologique (convulsions/psychose)
 9. Atteinte hématologique (anémie hémolytique, leucopénie, lymphopénie, thrombopénie)
 10. Anomalies immunologiques (anti-ADN natifs, anti-Sm, antiphospholipides)
 11. Anticorps antinucléaires (ANA+)
- Traitement : Corticoïdes + Hydroxychloroquine + Immunosuppresseurs (azathioprine, cyclophosphamide, mycophénolate)

2. DERMATOMYOSITE JUVÉNILE

- Définition : Maladie inflammatoire rare avec atteinte musculaire et cutanée.
- Caractéristiques :
 - Pic 5-10 ans, ♀ prédominante
 - Rarement néoplasique chez l'enfant
 - Physiopathologie : vasculite des petits vaisseaux
- Manifestations :
 - Musculaires : myasthénie proximale (difficulté à se lever, monter escaliers)
 - Cutanées : éruption héliotrope (paupières violacées), papules de Gottron, photosensibilité
 - Autres : fièvre, amaigrissement, calcinose sous-cutanées
- Biologie : CPK ↑, LDH ↑, aldolase ↑, anti-Mi-2, anti-p155/p140
- Traitement : Corticoïdes + Immunosuppresseurs (méthotrexate, azathioprine) + Rééducation + Photoprotection

MALADIES AUTO-IMMUNES CHEZ L'ENFANT (2)

3. SCLÉRODERMIE SYSTÉMIQUE

- Définition : Fibrose progressive de la peau et des organes internes.
- Physiopathologie : Dysfonction endothéliale → fibrose → dépôts de collagène
- Auto-anticorps : anti-centromère (forme limitée), anti-Scl 70 (forme diffuse)
- Manifestations :
 - Cutanées : sclérose, induration, phénomène de Raynaud
 - Pulmonaires : fibrose interstitielle, HTAP
 - Digestives : reflux, dysphagie, malabsorption
 - Rénales : crise rénale sclérodermique (URGENCE)
 - Cardiaques : troubles du rythme, fibrose myocardique
- Traitement : Vasodilatateurs + Immunosuppresseurs + IEC (crise rénale)

4. SYNDROME DE SJÖGREN

- Définition : Atteinte des glandes exocrines → xérostomie + xérophtalmie.
- Formes : Primaire (isolée) ou Secondaire (associée à LED, PR...)
- Manifestations :
 - Sécheresse buccale, oculaire, vaginale
 - Parotidomégalie bilatérale
 - Arthralgies, myalgies, fatigue chronique
 - Complications : vascularite, atteinte rénale, lymphome
- Biologie : ANA+, anti-SSA/Ro+, anti-SSB/La+, hypergammaglobulinémie, test de Schirmer +
- Traitement : Substituts salivaires/lacrymaux + Hydroxychloroquine ± Corticoïdes/Immunosuppresseurs

IV. DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

Catégorie	Exemples
Infectieux	Endocardite, tuberculose, EBV, CMV, VIH, leishmaniose
Inflammatoires non auto-immunes	Maladies auto-inflammatoires, sarcoïdose
Néoplasiques	Lymphomes, leucémies, syndromes paranéoplasiques
Médicamenteux	Lupus induit (hydralazine, isoniazide, anti-TNF)
Endocriniens/métaboliques	Thyroïdopathies, diabète, déficit vitamine D

V. DIAGNOSTIC DE GRAVITÉ

A) Gravité clinique

- Rénal : syndrome néphritique/néphrotique, IR, protéinurie >1g/24h
- Neurologique : convulsions, troubles conscience, myélite, encéphalite
- Cardiorespiratoire : péricardite, myocardite, HTAP, fibrose, hémorragie alvéolaire
- Hématologique : pancytopénie, hémolyse sévère, thrombopénie <50 000/mm³
- Autres : fièvre persistante, amaigrissement, vasculites diffuses, manifestations digestives graves

B) Gravité biologique

- Syndrome inflammatoire : VS, CRP ↑, hyperferritinémie >1000 ng/mL
- Auto-anticorps à haut titre : ANA, anti-dsDNA, ANCA, anti-Sm, anti-SSA/SSB
- Troubles fonctionnels : créatinine ↑, cytolyse, hypoxémie, CPK ↑, troponine ↑
- Hypocomplémentémie (C3, C4 bas) → activité lupique

C) Facteurs pronostiques défavorables

- Début aigu polyviscéral
- Réponse lente/incomplète au traitement
- Récidives fréquentes
- Atteinte précoce d'organe vital (rein, SNC, poumon)
- Complications infectieuses sous immunosuppresseurs

VI. POSOLOGIES DES IMMUNOSUPPRESSEURS (ANNEXE)

Médicament	Posologie	Médicament	Posologie
Prednisone	1-2 mg/kg/j (max 60 mg/j)	Cyclosporine	3-5 mg/kg/j en 2 prises
Cyclophosphamide	500-750 mg/m ² IV/4 semaines	Hydroxychloroquine	5-6 mg/kg/j (max 400 mg/j)
Azathioprine	1-3 mg/kg/j per os	Rituximab	375 mg/m ² IV/sem x 4 ou 750 mg/m ² J1-J15
Mycophénolate mofétil	600 mg/m ² /dose x 2/j (max 2g/j)	IgIV	2 g/kg sur 1-2 jours
Méthotrexate	10-15 mg/m ² /semaine (max 25) + acide folinique		